

Glipiform 500/5

(Metformin hydrochloride 500mg, Glibenclamide 5mg)

Thuốc bán theo đơn. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay của trẻ em.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa

Được chất: Metformin hydrochloride 500 mg
Glibenclamide 5 mg

Tá dược: Natri croscarmellose, povidon K30, microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, magnesi stearate, hypromellose 15cP, titan dioxide, PEG 400, quinoline yellow, oxid sắt vàng, oxid sắt đỏ.

CHỈ ĐỊNH

Thuốc được dùng trong điều trị bệnh đái tháo đường typ II, nhằm kiểm soát nồng độ đường huyết.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG**Cách dùng:**

Dùng đường uống. Chỉ dùng cho người lớn.

Tổng quát:

Giống như tất cả các thuốc hạ đường huyết, liều dùng GLIPEFORM phụ thuộc vào đáp ứng chuyển hóa của từng bệnh nhân (đường huyết, HbA1c).

Liều khởi đầu đối với bệnh nhân không sử dụng metformin là 500 mg x 1 lần/ngày. Nếu bệnh nhân không gặp phản ứng có hại đường tiêu hóa và cần tăng liều thì có thể dùng thêm 500 mg sau mỗi khoảng thời gian điều trị từ 1 - 2 tuần. Liều dùng metformin cần cần nhắc điều chỉnh trên từng bệnh nhân dựa trên hiệu quả và độ dung nạp của bệnh nhân. Liều tối đa được khuyến cáo là 2000 mg/ngày.

Khuyến cáo sử dụng thuốc trên bệnh nhân suy thận:

Đánh giá chức năng thận trước khi khởi đầu điều trị với metformin và đánh giá định kỳ sau đó.

Chống chỉ định metformin trên bệnh nhân có eGFR dưới 30 ml/phút/1,73m².

Không khuyến cáo khởi đầu điều trị với metformin ở bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 45 ml/phút/1,73m².

Ở bệnh nhân đang sử dụng metformin và có eGFR giảm xuống dưới 45 ml/phút/1,73m², đánh giá nguy cơ - lợi ích khi tiếp tục điều trị.

Ngưng sử dụng metformin nếu bệnh nhân có eGFR giảm xuống dưới 30 ml/phút/1,73m² [xem mục **Chống chỉ định và Thận trọng**].

Ngưng sử dụng metformin khi thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh có sử dụng thuốc cản quang chứa iod:

Trên những bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 60 ml/phút/1,73m², trên những bệnh nhân có tiền sử bệnh lý về gan, nghiện rượu hoặc suy tim, hoặc trên những bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cản quang chứa iod qua đường động mạch, ngừng metformin trước hoặc tại thời điểm thực hiện xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh có sử dụng thuốc cản quang chứa iod. Đánh giá lại chỉ số eGFR sau khi chiếu chụp 48 giờ, sử dụng lại metformin nếu chức năng thận ổn định [xem mục **Thận trọng**].

Khởi đầu điều trị:

Điều trị với sản phẩm phối hợp nên bắt đầu với liều tương đương liều của metformin và glibenclamide trước đây trên từng bệnh nhân. Khuyến cáo nên bắt đầu điều trị với liều thấp và tăng liều từ từ dựa trên kết quả xét nghiệm đường huyết.

Điều chỉnh liều:

Liều dùng nên được điều chỉnh mỗi 2 tuần hoặc lâu hơn, lượng gia tăng là 1 viên, dựa vào kết quả xét nghiệm đường huyết. Sự tăng liều từ từ có thể giúp dung nạp ở dạ dày ruột và ngăn ngừa sự khởi phát cơn hạ đường huyết.

Liều tối đa được khuyến cáo hàng ngày:

Liều tối đa được khuyến cáo hàng ngày là 3 viên GLIPEFORM 500/5. Trong những trường hợp ngoại lệ, có thể đề nghị tăng lên 4 viên GLIPEFORM 500/5 mỗi ngày.

Số lần dùng thuốc:

Dùng thuốc vào đầu bữa ăn. Số lần dùng thuốc phụ thuộc vào liều hàng ngày của từng bệnh nhân, như:

- Một lần mỗi ngày, vào buổi sáng khi ăn sáng, đối với liều 1 viên/ngày.
- Hai lần mỗi ngày, buổi sáng và buổi tối, đối với liều 2 hoặc 4 viên/ngày.
- Ba lần mỗi ngày, buổi sáng, buổi trưa và buổi tối, đối với liều 3 viên/ngày.

Số lần dùng thuốc nên được điều chỉnh theo thói quen ăn uống của từng bệnh nhân. Tuy nhiên, sau mỗi lần uống thuốc, phải dùng kèm một bữa ăn chứa carbohydrate cao đủ để ngăn ngừa sự khởi phát cơn hạ đường huyết.

Người cao tuổi:

nhân sử dụng metformin. Ở bệnh nhân có khả năng tăng nguy cơ suy thận (ví dụ như người cao tuổi), chức năng thận nên được đánh giá thường xuyên hơn.

- Ở bệnh nhân đang sử dụng metformin và có eGFR giảm xuống dưới 45 ml/phút/1,73m², đánh giá nguy cơ - lợi ích của việc tiếp tục phác đồ.

Tương tác thuốc: Sử dụng đồng thời metformin với một số thuốc có thể làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến metformin: bệnh nhân suy giảm chức năng thận dẫn tới những thay đổi đáng kể về mật huyết động, ảnh hưởng tới cân bằng acid - base hoặc làm tăng tích lũy metformin [xem mục **Tương tác thuốc**]. Vì vậy, cần nhắc theo dõi bệnh nhân thường xuyên hơn.

Bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên: Nguy cơ toan lactic liên quan đến metformin tăng lên theo tuổi của bệnh nhân, vì bệnh nhân cao tuổi có khả năng bị suy gan, suy thận, suy tim lớn hơn những bệnh nhân trẻ tuổi hơn. Cần đánh giá chức năng thận thường xuyên hơn đối với những bệnh nhân lớn tuổi.

Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán có sử dụng thuốc cản quang: Tiêm thuốc cản quang vào nội mạch ở những bệnh nhân đang điều trị metformin có thể dẫn tới suy giảm cấp tính chức năng thận và gây ra toan lactic. Ngưng sử dụng metformin trước hoặc tại thời điểm thực hiện chiếu chụp có sử dụng thuốc cản quang có chứa iod ở những bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 60 ml/phút/1,73m², những bệnh nhân có tiền sử suy gan, nghiện rượu, suy tim hoặc những bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc cản quang chứa iod theo đường động mạch. Đánh giá lại eGFR 48 giờ sau khi chiếu chụp và sử dụng lại metformin nếu chức năng thận ổn định.

Phẫu thuật hoặc các thủ thuật khác: Sự lưu giữ thức ăn và dịch trong quá trình phẫu thuật hoặc các thủ thuật khác có thể làm tăng nguy cơ giảm thể tích, tụt huyết áp và suy thận. Nên tạm thời ngừng sử dụng metformin khi bệnh nhân bị giới hạn lượng thức ăn và dịch nạp vào.

Tình trạng giảm oxy hít vào: Đã có ghi nhận một số ca nhiễm toan lactic liên quan đến metformin xảy ra trong suy tim sung huyết cấp (đặc biệt khi có kèm theo giảm tưới máu và giảm oxy huyết). Truy tìm mạch (sốc), nhồi máu cơ tim cấp, nhiễm khuẩn huyết và các bệnh lý khác liên quan đến giảm oxy huyết có liên quan với toan lactic và cũng có thể gây nito huyết trước thận. Khi những biến cố này xảy ra, ngừng metformin.

Uống rượu: Rượu có khả năng ảnh hưởng đến tác động của metformin lên chuyển hóa lactate và từ đó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến metformin. Cảnh báo bệnh nhân không uống rượu khi sử dụng metformin.

Suy gan: Bệnh nhân suy gan có thể tiến triển thành toan lactic liên quan đến metformin do suy giảm thải trừ lactate, dẫn tới tăng nồng độ lactate trong máu. Vì vậy, tránh sử dụng metformin trên những bệnh nhân đã được chẩn đoán bệnh gan thông qua các xét nghiệm hoặc lâm sàng.

Viêm tụy

Phải ngưng dùng thuốc khi viêm tụy kết hợp với nhiễm khuẩn hoặc tình trạng giảm oxy.

Glibenclamide**Hạ đường huyết**

Thuốc có thể gây nguy cơ khởi phát các cơn hạ đường huyết do chứa sulfonylurea. Hạ đường huyết có thể nghiêm trọng, kéo dài và gây tử vong gây ra bởi tất cả các sulfonylurea. Điều trị này chỉ nên dùng nếu bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn đều đặn (bao gồm cả bữa sáng). Quan trọng là chế độ ăn carbohydrate đều đặn do nguy cơ cao hạ đường huyết trước bữa ăn muộn, lượng carbohydrate không đủ hoặc mất cân bằng. Hạ đường huyết có nhiều khả năng xảy ra khi chế độ ăn hạn chế năng lượng, sau khi tập thể dục gắng sức hoặc kéo dài, sau khi uống rượu hoặc khi dùng phối hợp các thuốc hạ đường huyết. Dùng glibenclamide ở người cao tuổi có thể dẫn đến nguy cơ hạ đường huyết cao hơn ở người trẻ tuổi. Hạ đường huyết có thể nặng hơn và kéo dài hơn ở người cao tuổi.

Xử trí hạ đường huyết: Các triệu chứng hạ đường huyết trung bình không làm mất ý thức hoặc các biểu hiện thần kinh nên được điều chỉnh bằng cách ăn đường ngay lập tức. Phải đảm bảo điều chỉnh liều lượng và/hoặc thay đổi chế độ ăn. Các phản ứng hạ đường huyết nghiêm trọng, hôn mê, co giật hoặc các dấu hiệu thần kinh khác cũng có thể xảy ra và gây ra tình trạng cấp cứu y khoa cần điều trị ngay với glucose tiêm tĩnh mạch

Liều dùng nên được điều chỉnh tùy thuộc vào các thông số chức năng thận. Nên bắt đầu điều trị với một viên metformin hydrochloride 250 mg/glibenclamide 1,25 mg mỗi ngày, cần thường xuyên kiểm tra chức năng thận để điều chỉnh liều dựa trên kết quả xét nghiệm.

Trẻ em:

Không khuyến cáo sử dụng thuốc cho trẻ em và thanh thiếu niên.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không dùng thuốc trong các trường hợp sau:

- Bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với metformin hydrochloride, glibenclamide, sulfonyleurea hoặc sulfonamide khác hoặc với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Nhiễm toan chuyển hóa cấp tính hoặc mạn tính (bao gồm cả nhiễm toan ceton do đái tháo đường, nhiễm toan lactic).
- Tiến hôn mê do đái tháo đường.
- Rối loạn chức năng thận (độ thanh thải creatinine < 60 ml/phút), bệnh nhân suy thận nặng (eGFR < 30 ml/phút/1,73m²) [xem mục *Thận trọng*].
- Các tình trạng cấp tính có tiềm năng làm thay đổi chức năng thận như: mất nước, nhiễm trùng nặng, sốc, tiêm các chất cản quang chứa iod vào nội mạch.
- Bệnh cấp tính hoặc mạn tính có thể gây giảm oxy mô như suy tim hay suy hô hấp, nhồi máu cơ tim gần đây, sốc, mất máu đáng kể cấp tính, nhiễm trùng, hoại tử.
- Phẫu thuật lớn.
- Suy gan, ngộ độc rượu cấp, nghiện rượu.
- Rối loạn chuyển hóa porphyrin.
- Rối loạn chuyển hóa đường galactose bẩm sinh, hội chứng kém hấp thu glucose và galactose hoặc thiếu men lactase.
- Phụ nữ cho con bú.
- Dùng chung với miconazole.

THẬN TRỌNG

Metformin hydrochloride

Nhiễm toan lactic:

Đã có ghi nhận những ca nhiễm toan lactic liên quan đến metformin, bao gồm cả trường hợp tử vong, giảm thân nhiệt, tụt huyết áp, loạn nhịp chậm kéo dài. Khởi phát của tình trạng nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin thường không dễ phát hiện, kèm theo các triệu chứng không điển hình như khó chịu, đau cơ, suy hô hấp, lơ mơ và đau bụng. Nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin được đặc trưng bởi nồng độ lactate tăng lên trong máu (> 5 mmol/lít), khoảng trống anion (không có bằng chứng của keto niệu hoặc keto máu), tăng tỷ lệ lactate/pyruvate và nồng độ metformin huyết tương tăng > 5 mcg/ml.

Yếu tố nguy cơ của nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin bao gồm suy thận, sử dụng đồng thời với một số thuốc (ví dụ các chất ức chế carbonic anhydrase như topiramate), từ 65 tuổi trở lên, có thực hiện chiếu chụp sử dụng thuốc cản quang, phẫu thuật và thực hiện các thủ thuật khác, tình trạng giảm oxy hít vào (ví dụ suy tim sung huyết cấp), uống nhiều rượu và suy gan.

Các biện pháp giảm thiểu nguy cơ và xử trí nhiễm toan acid lactic liên quan đến metformin ở nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao được trình bày bên dưới.

Nếu nghi ngờ có toan lactic liên quan đến metformin, nên ngừng sử dụng metformin, nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện và tiến hành các biện pháp xử trí. Ở những bệnh nhân đã điều trị với metformin, đã được chẩn đoán toan lactic hoặc nghi ngờ có khả năng cao bị toan lactic, khuyến cáo nhanh chóng lọc máu để điều chỉnh tình trạng nhiễm toan và loại bỏ phần metformin đã bị tích lũy (metformin hydrochloride có thể thẩm tách được với độ thanh thải 170 ml/phút trong điều kiện huyết động lực tốt). Lọc máu có thể làm đảo ngược triệu chứng và hồi phục.

Hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà về các triệu chứng của toan lactic và nếu những triệu chứng này xảy ra, cần ngừng thuốc và báo cáo những triệu chứng này cho bác sĩ.

Đối với mỗi yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm toan lactic liên quan đến metformin, những khuyến cáo nhằm giúp giảm thiểu nguy cơ và xử trí tình trạng toan lactic liên quan đến metformin, cụ thể như sau:

Suy thận: Những ca nhiễm toan lactic liên quan đến metformin được ghi nhận xảy ra chủ yếu trên những bệnh nhân bị suy thận nặng. Nguy cơ tích lũy metformin và nhiễm toan lactic liên quan đến metformin tăng lên theo mức độ nghiêm trọng của suy thận bởi metformin được thải trừ chủ yếu qua thận. Khuyến cáo làm sàng dựa trên chức năng thận của bệnh nhân bao gồm [xem mục *Liều dùng và cách sử dụng*]:

- Trước khi khởi đầu điều trị với metformin cần ước tính mức độ lọc cầu thận (eGFR) của bệnh nhân.
- Chống chỉ định metformin trên bệnh nhân có eGFR < 30 ml/phút/1,73m² [xem mục *Chống chỉ định*].
- Không khuyến cáo khởi đầu điều trị với metformin ở bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 30 - 45 ml/phút/1,73m².
- Thu thập dữ liệu về eGFR ít nhất 1 lần/năm ở tất cả các bệnh

ngay khi nguyên nhân được chẩn đoán hoặc nghi ngờ.

Chọn liều dùng phù hợp và hướng dẫn đầy đủ cho bệnh nhân là rất quan trọng để giảm nguy cơ hạ đường huyết. Nếu bệnh nhân gặp phải các đợt hạ đường huyết lặp lại, hoặc nặng hoặc không nhận thức được, thì nên xem xét các phương pháp điều trị thuốc chống đái tháo đường khác.

Cần theo dõi cẩn thận các yếu tố nguy cơ hạ đường huyết:

- Bệnh nhân không hợp tác (đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi), bệnh nhân suy nhược.
- Bệnh nhân từ 65 tuổi trở lên: Khuyến cáo ở những bệnh nhân này không được điều chỉnh lên liều tối đa để tránh nguy cơ hạ đường huyết.
- Suy dinh dưỡng, chế độ ăn không điều độ, bỏ bữa, ăn kiêng hay thay đổi chế độ ăn.
- Tập thể dục nặng và kéo dài, thiếu cân bằng giữa tập thể dục và lượng dùng carbohydrate.
- Suy thận.
- Suy gan nặng.
- Dùng thuốc quá liều.
- Rối loạn nội tiết: Suy giáp, suy tuyến yên và tuyến thượng thận.
- Uống rượu.
- Dùng đồng thời một số loại thuốc khác, đặc biệt là các thuốc điều trị đái tháo đường khác.

Việc điều chỉnh liều cũng phải được xem xét bất cứ khi nào thay đổi cân nặng, thay đổi lối sống của bệnh nhân hoặc các yếu tố khác làm tăng tính nhạy cảm với hạ đường huyết hoặc tăng đường huyết.

Tuổi từ 65 tuổi trở lên đã được xác định là một yếu tố nguy cơ hạ đường huyết ở bệnh nhân điều trị với sulfonyleurea. Hạ đường huyết có thể khó nhận ra ở người cao tuổi. Liều khởi đầu và liều duy trì glibenclamide phải được điều chỉnh cẩn thận để giảm nguy cơ hạ đường huyết.

Suy thận và suy gan

Được động học và/hoặc dược lực học của thuốc có thể bị thay đổi ở những bệnh nhân suy gan hoặc suy thận nặng. Suy gan hoặc suy thận có thể làm tăng nồng độ glibenclamide huyết thanh và suy gan cũng có thể làm giảm khả năng tân tạo đường. Nếu hạ đường huyết xảy ra ở những bệnh nhân này, phải tiến hành điều trị thích hợp.

Thời gian bán thải của glibenclamide có thể kéo dài nếu có hiện diện của một khiếm khuyết di truyền trong quá trình trao đổi chất.

Khả năng nhạy cảm chéo với sulfonamide và dẫn xuất của nó.

Thận trọng khác

- Bệnh đái tháo đường typ I cần được điều trị bằng insulin.
- Không nên dùng thuốc nếu bệnh đái tháo đường có thể được điều chỉnh bằng chế độ ăn.
- Các xét nghiệm lâm sàng và các xét nghiệm thông thường để theo dõi bệnh đái tháo đường, bao gồm việc xác định lượng đường trong máu, nên được thực hiện thường xuyên. Điều này cho phép xác định liều tối thiểu có hiệu quả và phát hiện sự thất bại trong điều trị ban đầu (giảm nồng độ glucose máu thấp ở liều khuyến cáo tối đa) hoặc thất bại thứ phát (mất kiểm soát nồng độ glucose máu sau giai đoạn đầu điều trị có hiệu quả). Các phép đo đường hóa hemoglobin cũng có thể có ích trong việc theo dõi đáp ứng của bệnh nhân đối với điều trị thuốc.
- Đánh giá định kỳ chức năng thận, gan, tim mạch và lượng vitamin B12 cũng được khuyến cáo khi điều trị kéo dài với thuốc.
- Mất cân bằng đường trong máu: Trong trường hợp phẫu thuật hoặc căng thẳng bất thường (ví dụ: sốt, nhiễm khuẩn) hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác gây mất bù, nên điều trị bằng insulin tạm thời thay cho điều trị này.

Không nên dùng thuốc này cho bệnh nhân có các vấn đề về di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose, thiếu hụt lactase toàn phần hoặc kém hấp thu glucose - galactose.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thời kỳ mang thai:

Thông tin gần đây cho thấy nồng độ đường huyết bất thường trong thai kỳ liên quan tới các bất thường bẩm sinh có tỷ lệ cao hơn. Hầu hết các chuyên gia khuyến rằng insulin nên được sử dụng trong thai kỳ để duy trì mức đường huyết càng gần bình thường càng tốt. Bởi vì nghiên cứu trên động vật sinh sản không phải luôn luôn dự đoán đúng trên người, thuốc không nên được sử dụng trong khi mang thai trừ khi thật cần thiết.

Chưa có nghiên cứu đầy đủ và có kiểm soát ở phụ nữ có thai với thuốc hay với từng thành phần riêng lẻ. Không có nghiên cứu trên động vật với thuốc phối hợp. Các dữ liệu sau đây dựa trên những phát hiện trong nghiên cứu được thực hiện với từng thành phần riêng lẻ.

Glibenclamide

Các nghiên cứu trên động vật sinh sản đã được thực hiện ở chuột và thỏ với liều lên đến 500 lần liều tối đa dùng hàng ngày ở người (20 mg glibenclamide thành phần của thuốc phối hợp) dựa trên diện tích bề mặt cơ thể, và nhận thấy không có bằng chứng về suy giảm khả năng sinh sản hoặc tổn hại cho thai nhi do dùng glibenclamide.

Metformin hydrochloride

Dùng metformin đơn độc không gây quái thai ở chuột cống và thỏ với liều lên đến 600 mg/kg/ngày - liều gấp 2 - 6 lần liều tối đa hàng ngày ở người (2000 mg metformin thành phần của thuốc phối hợp) dựa trên diện tích bề mặt cơ thể so với chuột và thỏ, tương ứng. Xác định nồng độ bào thai đã cho thấy một phần hàng rào nhau thai đối với metformin.

Thời kỳ cho con bú:

Một vài thuốc sulfonylurea được bài tiết qua sữa mẹ, tuy nhiên, chưa biết glibenclamide có được bài tiết qua sữa mẹ hay không. Nghiên cứu ở chuột cho con bú cho thấy metformin được bài tiết vào sữa và đạt mức tương đương với trong huyết tương. Nghiên cứu tương tự không được tiến hành với các bà mẹ cho con bú. Bởi vì khả năng hạ đường huyết ở trẻ bú mẹ có thể tồn tại, nên quyết định cho trẻ ngưng bú hoặc ngưng sử dụng thuốc, phụ thuộc vào tầm quan trọng của thuốc đối với người mẹ. Nếu ngưng sử dụng thuốc, và nếu chỉ có chế độ ăn uống là không đủ để kiểm soát lượng đường huyết, nên xem xét điều trị bằng insulin.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC

Bệnh nhân phải được cảnh báo về những triệu chứng hạ đường huyết và cần phải thận trọng khi lái xe hoặc vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Các phối hợp bị chống chỉ định:

Liên quan đến glibenclamide: Miconazole (dùng đường toàn thân, gel niêm mạc): Tăng tác dụng hạ đường huyết, có thể xuất hiện các triệu chứng hạ đường huyết hoặc thậm chí hôn mê.

Liên quan đến metformin: Các chất cản quang có chứa iod: Phải ngưng dùng thuốc hoặc 48 giờ trước khi làm xét nghiệm nếu chức năng thận đã bị suy giảm, hoặc từ thời điểm xét nghiệm nếu chức năng thận bình thường.

Các phối hợp không khuyến cáo:

Liên quan đến glibenclamide: Bosentan: Nguy cơ tăng độc tính gan khi bosentan được dùng chung với glibenclamide. Nên tránh dùng chung. Hiệu quả hạ đường huyết của glibenclamide cũng có thể bị giảm.

Liên quan đến sulfonylurea: Phenylbutazone (dùng đường toàn thân): Tăng tác dụng hạ đường huyết của sulfonylurea (thay thế vị trí gắn kết protein của sulfonylurea và/hoặc giảm thải trừ). Nên dùng thuốc chống viêm khác ít bị tương tác, hoặc cảnh báo bệnh nhân và tăng cường theo dõi, nếu cần thiết, điều chỉnh liều lượng trong quá trình điều trị với thuốc chống viêm và sau khi ngừng thuốc.

Các phối hợp cần thận trọng:

Liên quan đến metformin:

Cimetidine: Giảm độ thanh thải của metformin đã được báo cáo trong nghiên cứu tương tác dược động học cimetidine.

Thuốc chống đông: Metformin làm tăng thải trừ các chất đối kháng vitamin K trong nghiên cứu tương tác dược động học.

Nifedipine: Dùng đồng thời metformin và nifedipine sẽ làm C_{max} và AUC huyết tương của metformin tăng lên 20% và 9%, và tăng lượng metformin bài tiết trong nước tiểu. T_{max} và thời gian bán thải của metformin không bị ảnh hưởng. Nifedipine dường như làm tăng hấp thu metformin. Metformin có ảnh hưởng rất nhỏ đến dược động học của nifedipine.

Các chất vận chuyển cation hữu cơ (OCT): Metformin là cơ chất của cả hai chất vận chuyển OCT1 và OCT2. Dùng đồng thời metformin với:

- Cơ chất/chất ức chế OCT1 (như verapamil) có thể làm giảm hiệu quả của metformin.

- Chất cảm ứng OCT1 (như rifampicin) có thể làm tăng sự hấp thu dạ dày ruột và tăng hiệu quả.

- Cơ chất/chất ức chế OCT2 (như cimetidine, dolutegravir, crizotinib, olaparib, dactatasvir, vandetanib) có thể làm giảm thải trừ của metformin qua thận và do đó làm tăng nồng độ metformin trong huyết tương.

Vì vậy, nên thận trọng khi dùng đồng thời các thuốc này với metformin và có thể xem xét điều chỉnh liều, đặc biệt ở bệnh nhân suy thận.

Liên quan đến glibenclamide:

Fluconazole: Tăng thời gian bán thải của sulfonylurea, có thể xuất hiện các triệu chứng hạ đường huyết. Cảnh báo bệnh nhân và tăng cường kiểm tra glucose trong máu, và có thể điều chỉnh liều lượng thuốc chống nấm nếu cần thiết trong quá trình điều trị với fluconazole và sau khi ngừng thuốc.

Tương tác được lực học:

Các phối hợp không khuyến cáo:

Liên quan đến metformin:

Rượu: Tăng nguy cơ nhiễm toan lactic trong nhiễm độc rượu cấp tính, đặc biệt trong trường hợp ăn kiêng hoặc kém dinh dưỡng và suy gan. Tránh uống thức uống có cồn và thuốc có chứa cồn.

Liên quan đến sulfonylurea:

Rượu: Rất hiếm trường hợp xảy ra sự không dung nạp rượu. Phản ứng giống disulfiram rất hiếm khi xảy ra sau khi dùng đồng thời rượu và glibenclamide. Tác dụng disulfiram này đã được báo cáo với các sulfonylurea khác, đặc biệt là đối với

rất hiếm gặp (< 0,01%) nhưng biến chứng về chuyển hóa rất nghiêm trọng có thể xảy ra do sự tích lũy metformin trong quá trình điều trị với metformin.

Khởi phát của tình trạng nhiễm toan lactic thường khó phát hiện và đi kèm với các triệu chứng không điển hình như khó chịu, đau cơ, suy hô hấp, lơ mơ và đau bụng. Có thể xuất hiện hạ thân nhiệt, hạ huyết áp và loạn nhịp tim chậm. Bệnh nhân và bác sĩ điều trị phải biết được tầm quan trọng của những triệu chứng như thế và bệnh nhân nên được hướng dẫn để thông báo ngay cho bác sĩ nếu triệu chứng xuất hiện. Nhiễm toan lactic có thể bị nghi ngờ ở bệnh nhân đái tháo đường có nhiễm toan chuyển hóa thiếu bằng chứng về nhiễm toan thể ceton (ceton niệu và ceton máu).

Nhiễm toan lactic là một cấp cứu y khoa phải được điều trị tại bệnh viện. Ở bệnh nhân nhiễm toan lactic đang dùng metformin, nên ngưng dùng thuốc ngay lập tức và cần tiến hành ngay các biện pháp hỗ trợ chung.

Giảm hấp thu và giảm nồng độ huyết thanh vitamin B12 đã được ghi nhận ở những bệnh nhân được điều trị lâu dài với metformin. Khuyến cáo xem xét nguy cơ bệnh nhân nếu bệnh nhân có biểu hiện chứng thiếu máu hồng cầu to. Do đó, nên theo dõi nồng độ B12 trong huyết thanh hoặc xem xét bổ sung B12 đường tiêm định kỳ.

Rối loạn gan mật: Rất hiếm gặp: Các xét nghiệm chức năng gan bất thường hoặc viêm gan, cần ngưng điều trị.

Rối loạn da và mô dưới da: Các phản ứng trên da như ban đỏ, ngứa và mày đay đã được báo cáo nhưng tỷ lệ mắc rất hiếm gặp (< 0,01%).

Rối loạn hệ thần kinh trung ương: Thường gặp rối loạn vị giác (3%).

Glibenclamide

Kinh nghiệm lâm sàng trong việc sử dụng glibenclamide đã chỉ ra rằng các tác dụng phụ nghiêm trọng buộc phải ngừng điều trị là ít gặp, ngay cả trong điều trị dài hạn. Tuy nhiên, nếu các tác dụng phụ vẫn tồn tại, nên ngưng dùng thuốc.

Rối loạn tiêu hóa: Các rối loạn đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đầy thượng vị, cảm giác khó chịu, chán ăn, ợ nóng, khó tiêu và tiêu chảy là những tác dụng phụ thường gặp nhất đối với riêng glibenclamide, xảy ra khoảng 1 - 2% bệnh nhân. Glibenclamide gây ra các tác dụng phụ đường tiêu hóa dường như có liên quan đến liều và có thể giảm dần sau khi giảm liều.

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng: Hạ đường huyết không những nghiêm trọng mà còn kéo dài và gây tử vong. Phản ứng giống disulfiram khi uống chung với rượu.

Rối loạn gan mật: Rối loạn chuyển hóa porphyrin gan, tăng men gan (AST, ALT), chức năng gan bất thường, ứ mật, viêm gan ứ mật, viêm gan dạng u hạt và bilirubin máu đã được báo cáo với sulfonylurea.

Rối loạn da và mô dưới da: Phản ứng da và màng nhầy: ngứa, ban đỏ, mày đay, phát ban dạng sẩn và phát ban dạng bong rộp hoặc phát ban dạng vảy nến xảy ra ở 1,5% bệnh nhân được điều trị với glibenclamide; nếu phản ứng da vẫn cứ dai dẳng, nên ngưng dùng thuốc.

Các biểu hiện ở da do rối loạn chuyển hóa porphyrin, sự thay đổi giống bệnh pellagra (pellagra-like changes) đã được báo cáo với sulfonylurea. Một vài trường hợp nhạy cảm với ánh sáng đã được báo cáo. Rất hiếm trường hợp được báo cáo về viêm mạch dị ứng da hoặc nội tạng, viêm da tróc da và nổi mày đay tiến triển thành sốc.

Có thể xảy ra phản ứng chéo với sulfonamide và các dẫn xuất của nó.

Rối loạn mắt: Rối loạn thị giác thoáng qua có thể xảy ra khi bắt đầu điều trị do giảm đường huyết.

Rối loạn máu và hệ bạch huyết: Rối loạn huyết học, có thể hồi phục khi ngừng điều trị: giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu, ban xuất huyết giảm tiểu cầu; Hiếm gặp hơn: mất bạch cầu hạt, tăng bạch cầu ái toan, thiếu máu tán huyết, thiếu máu không tái tạo, bất sản tủy xương, giảm toàn thể huyết cầu và rối loạn đông máu.

Khác: Thỉnh thoảng tăng nồng độ urea và creatinine huyết tương từ trung bình đến vừa. Giảm natri máu.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ

Glibenclamide: Quá liều sulfonylurea, bao gồm viên nén glibenclamide, có thể gây hạ đường huyết. Triệu chứng hạ đường huyết nhẹ, không mất ý thức hoặc các dấu hiệu thần kinh, cần được điều trị tích cực với glucose uống và điều chỉnh liều lượng thuốc và/hoặc khẩu phần bữa ăn. Giám sát chặt chẽ cho đến khi bác sĩ đảm bảo rằng bệnh nhân không còn nguy hiểm.

Hạ đường huyết nặng, với tình trạng hôn mê, co giật, hoặc các rối loạn thần kinh khác xảy ra không thường xuyên, nhưng cần nhập viện ngay lập tức. Nếu chẩn đoán hoặc nghi ngờ hôn mê do hạ đường huyết, bệnh nhân cần được tiêm tĩnh mạch nhanh dung dịch glucose đậm đặc (50%). Sau đó, truyền liên tục dung

chlorpropamide, glibenclamide, glipizide, tolbutamide. Uống quá nhiều rượu có thể tăng nguy cấp tình trạng hạ đường huyết (bằng cách ức chế phản ứng đền bù hoặc làm chậm sự bất hoạt chuyển hóa), điều này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự khởi phát hôn mê hạ đường huyết. Tránh uống rượu và các loại thuốc chứa cồn.

Liên quan đến tất cả các thuốc chống đái tháo đường:

Danazol: Nếu không thể tránh được sự kết hợp này, cảnh báo bệnh nhân và tăng cường theo dõi lượng đường trong máu. Có thể điều chỉnh liều lượng thuốc chống đái tháo đường trong quá trình điều trị với danazol và sau khi ngừng thuốc.

Các phối hợp cần thận trọng:

Liên quan đến metformin:

Thuốc lợi tiểu: Nhiễm toan lactic do metformin gây ra bởi sự suy giảm chức năng thận, liên quan đến thuốc lợi tiểu và đặc biệt hơn đối với thuốc lợi tiểu quai. Liệu pháp lợi tiểu thiazide có thể làm giảm dung nạp glucose. Có thể cần phải điều chỉnh liều metformin.

Các thuốc chẹn kênh calci có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát glucose ở bệnh nhân đái tháo đường.

Thuốc chẹn beta: Dùng đồng thời metformin và các thuốc chẹn beta có thể làm tăng tác dụng chống tăng đường huyết. Nên theo dõi đường huyết trong quá trình điều chỉnh liều của một trong hai thuốc.

Liên quan đến glibenclamide:

Các thuốc được dùng đồng thời như sulfonylurea có thể gây trầm cảm không mong muốn hoặc tăng nồng độ đường trong máu.

Thuốc chẹn beta, clonidine, reserpine, guanethidine và các chất kích thích thần kinh giao cảm: Tất cả các thuốc này che dấu một số triệu chứng hạ đường huyết: đánh trống ngực và nhịp tim nhanh. Hầu hết các thuốc chẹn beta không chọn lọc làm tăng tỷ lệ mắc và mức độ trầm trọng của hạ đường huyết. Cảnh báo bệnh nhân và tăng cường theo dõi lượng đường trong máu, đặc biệt là khi bắt đầu điều trị.

Các thuốc có thể làm tăng tác dụng hạ đường huyết của glibenclamide: Các hormone đồng hóa (anabolic steroid), bezafibrate, chloramphenicol, clofibrate, co-trimoxazol, dẫn xuất coumarin, disopyramide, fenfluramine, fluoxetine, gemfibrozil, guanethidine, heparin, chất ức chế MAO, các thuốc chống viêm không steroid, oxypentifylline (đường tiêm, liều cao), phenylbutazone, phosphamid, probenecid, thuốc kháng sinh quinolon, salicylate, sulphapyrazone, các hợp chất tetracycline và một số sulfonamide tác dụng kéo dài.

Các thuốc có thể làm giảm tác dụng hạ đường huyết của glibenclamide: Acetazolamide, thuốc chẹn kênh calci, cimetidine, diazoxide, glucagon, isoniazid, nicotinic acid (liều cao), estrogen, progestogen, dẫn chất phenothiazine, phenytoin, ranitidine, rifampicin, các thuốc lợi tiểu muối, các thuốc kích thích thần kinh giao cảm, hormone tuyến giáp và liều cao thuốc nhuận tràng.

Liên quan đến tất cả các thuốc chống đái tháo đường:

Chlorpromazine: Ở liều cao (100 mg/ngày chlorpromazine), tăng đường huyết (giảm sự giải phóng insulin). Thận trọng khi sử dụng: cảnh báo bệnh nhân và tăng cường theo dõi lượng đường trong máu. Có thể điều chỉnh liều dùng thuốc chống đái tháo đường trong quá trình điều trị thuốc an thần và sau khi ngừng thuốc.

Corticosteroid (glucocorticoid) và tetracosactid (dùng đường toàn thân và tại chỗ): Tăng nồng độ glucose huyết đôi khi đi kèm với ketosis (giảm dung nạp carbohydrate với corticosteroid). Thận trọng khi sử dụng: cảnh báo bệnh nhân và tăng cường theo dõi lượng đường trong máu. Có thể điều chỉnh liều lượng thuốc chống đái tháo đường trong thời gian điều trị bằng corticosteroid và sau khi ngừng thuốc.

Các chất chủ vận β_2 : Tăng đường huyết do chất chủ vận β_2 . Thận trọng khi sử dụng: cảnh báo bệnh nhân, tăng cường theo dõi lượng đường trong máu và có thể chuyển sang liệu pháp insulin.

Chất ức chế enzyme chuyển angiotensin (ACE) (ví dụ: captopril, enalapril): Chất ức chế ACE có thể làm giảm lượng đường trong máu. Nếu cần, hãy điều chỉnh liều dùng trong quá trình điều trị với chất ức chế ACE và khi ngưng thuốc.

Tương tác khác - Các phối hợp cần được xem xét:

Liên quan đến glibenclamide:

Desmopressin: Giảm tác dụng thuốc chống lợi tiểu.

Ảnh hưởng đối với các xét nghiệm:

Không có thông tin về ảnh hưởng của metformin hoặc glibenclamide trên các xét nghiệm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Metformin

Rối loạn tiêu hóa: Các triệu chứng đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng và chán ăn rất thường gặp (> 10%); những triệu chứng này xảy ra thường xuyên nhất khi bắt đầu điều trị. Để ngăn ngừa các triệu chứng đường tiêu hóa này, nên dùng thuốc 2 hoặc 3 liều hàng ngày. Việc tăng liều chậm cũng có thể cải thiện khả năng dung nạp dạ dày ruột.

Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng: Nhiễm toan lactic

dịch glucose loãng hơn (10%) để duy trì đường huyết ở mức trên 100 mg/dL. Bệnh nhân nên được theo dõi chặt chẽ trong ít nhất 24 - 48 giờ, bởi vì hạ đường huyết có thể trở lại sau khi phục hồi biểu hiện lâm sàng.

Metformin hydrochloride: Quá liều metformin hydrochloride đã xảy ra, bao gồm cả dùng một lượng lớn hơn 50 gam. Hạ đường huyết đã được báo cáo khoảng 10% trường hợp, nhưng không có mối liên hệ nhân quả với metformin hydrochloride. Nhiễm toan lactic đã được báo cáo khoảng 32% trường hợp quá liều metformin. Metformin có thể thẩm phân với độ thanh thải lên đến 170 ml/phút trong điều kiện huyết động tốt. Do đó, thẩm phân máu có thể hữu ích để loại bỏ thuốc tích lũy ở những bệnh nhân nghi ngờ quá liều metformin.

ĐƯỢC LỰC HỌC

GLIPEFORM 500/5 là thuốc kết hợp 2 được chất điều trị đái tháo đường glibenclamide và metformin hydrochloride với cơ chế tác động bổ sung cho nhau, để kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân đái tháo đường typ II.

Metformin hydrochloride là thuốc chống đái tháo đường nhóm biguanide, cải thiện khả năng dung nạp glucose ở bệnh nhân đái tháo đường typ II, làm giảm cả glucose huyết tương cơ bản và sau khi ăn. Metformin hydrochloride làm giảm sự tạo glucose ở gan, giảm hấp thu glucose ở ruột, tăng sự nhạy cảm insulin bằng cách tăng hấp thu và sử dụng glucose ở ngoại vi.

Glibenclamide là thuốc hạ đường huyết nhóm sulfonylurea thế hệ 2, gây hạ đường huyết cấp bằng cách kích thích tiết insulin ở tuyến tụy, tác dụng này phụ thuộc vào tế bào chức năng beta trong đảo tụy. Cơ chế làm giảm glucose máu khi điều trị dài hạn glibenclamide chưa được biết đầy đủ. Dùng thuốc trong thời gian dài ở bệnh nhân đái tháo đường typ II, tác dụng hạ đường huyết vẫn còn mặc dù có sự giảm dần trong đáp ứng bài tiết insulin với thuốc. Tác dụng ngoài tụy có thể liên quan đến cơ chế tác động của thuốc hạ đường huyết sulfonylurea dùng đường uống.

ĐƯỢC ĐỘNG HỌC

Liên quan đến sự kết hợp

Sinh khả dụng của metformin và glibenclamide khi kết hợp tương tự như khi dùng đồng thời 1 viên glibenclamide và 1 viên metformin. Sinh khả dụng của metformin và sinh khả dụng của glibenclamide khi kết hợp không bị ảnh hưởng bởi thức ăn, nhưng tăng tốc độ hấp thu của glibenclamide.

Liên quan đến metformin

Hấp thu: Nồng độ tối đa đạt được sau 2,5 giờ sau khi uống. Sinh khả dụng tuyệt đối của metformin 500 mg hoặc 850 mg khoảng 50 - 60%. Sau khi uống, phần không hấp thu được tìm thấy trong phân là 20 - 30%.

Phân bố: Metformin liên kết với protein huyết tương không đáng kể. Metformin phân bố vào trong hồng cầu. Nồng độ đỉnh trong máu thấp hơn trong huyết tương và xuất hiện với khoảng thời gian xấp xỉ nhau. Thể tích phân bố trung bình từ 63 - 276 lít.

Chuyển hóa: Metformin được đào thải dưới dạng không đổi trong nước tiểu. Không có chất chuyển hóa nào được tìm thấy ở người.

Thải trừ: Độ thanh thải ở thận của metformin là > 400 ml/phút, cho thấy rằng metformin được đào thải qua sự lọc ở cầu thận và bài tiết ở ống thận. Sau khi uống, thời gian bán thải khả kiến khoảng 6,5 giờ. Khi chức năng thận bị suy giảm, sự thanh thải ở thận giảm theo tỷ lệ của creatinine và vì thế thời gian bán thải kéo dài, dẫn đến tăng nồng độ metformin trong huyết tương.

Liên quan đến glibenclamide

Hấp thu: Glibenclamide được hấp thu đáng kể (> 95%) sau khi uống. Nồng độ đỉnh trong huyết tương đạt được sau khoảng 4 giờ.

Phân bố: Glibenclamide liên kết mạnh với albumin huyết tương (99%), điều này có thể giải thích cho vài tương tác thuốc.

Chuyển hóa: Glibenclamide được chuyển hóa hoàn toàn ở gan thành 2 chất chuyển hóa. Suy tế bào gan làm giảm sự chuyển hóa và làm chậm đáng kể sự đào thải.

Thải trừ: Glibenclamide được bài tiết ở dạng chất chuyển hóa qua mật (60%) và nước tiểu (40%), sự đào thải hoàn toàn trong vòng 45 - 72 giờ. Thời gian bán thải khả kiến từ 4 - 11 giờ. Sự bài tiết của chất chuyển hóa ở mật tăng trong trường hợp suy thận, theo mức độ suy thận cho đến khi độ thanh thải của creatinine là 30 ml/phút. Vì vậy, sự đào thải glibenclamide không bị ảnh hưởng bởi suy thận miễn sao sự thanh thải creatinine vẫn còn giữ trên 30 ml/phút.

HẠN DỤNG 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN Dưới 30°C. Tránh ẩm và ánh sáng.

TIÊU CHUẨN TCCS.

TRÌNH BÀY Hộp 02 vỉ x 15 viên.

Hộp 03 vỉ x 10 viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO

166 - 170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

VNNT280-00